

Pornografia — *ocena kliniczna*

Większość użytkowników nie ma problemu. Niektórzy — tak. Klucz: ocena konsekwencji, nie ideologia. Pytanie nie brzmi „czy ile”, lecz „z jakim skutkiem”.

CZAS: 12 min Diagnostyka różnicowa **ŹRÓDŁO:** Grubbs i wsp. (2019); Kraus i wsp. (2016)

JAK UŻYWAĆ

1 · Poznaj 4 sygnały kliniczne, które wymagają interwencji (sekcja 01) — tolerancja, utrata kontroli, eskalacja, wpływ na relacje. **2** · Zrozum, dlaczego *perceived addiction* (postrzegane uzależnienie) wymaga **innej** interwencji niż CSBD (sekcja 02). **3** · Wykonaj samoocenę 6 obszarów (sekcja 03). **4** · Jeśli mieszkasz z partnerem/-ką — poznaj zasady rozmowy o pornografii w związku (sekcja 04).

DLACZEGO TO DZIAŁA

Kompulsywne użycie pornografii to *najczęstsza* forma CSBD w praktyce klinicznej (Kraus i wsp. 2018). Stan debaty klinicznej jest **niepewny**: linia uzależnieniowa (Wilson 2014) postuluje, że pornografia zmienia układ nagrody jak narkotyki; linia sceptyczna (Prause i wsp. 2015) wykazała brak dowodów na analogię substancyjną i argumentuje, że problem to *postrzegane uzależnienie* — cierpienie wynika z **przekonania** o uzależnieniu, nie z mechanizmu uzależnieniowego. Grubbs i wsp. (2019) opisali fenomen *moralnej inkongruencji* — osoby o konserwatywnych przekonaniach religijnych częściej identyfikują normalne zachowania (1–2 epizody tygodniowo) jako „uzależnienie”, co zwiększa cierpienie **bez** realnego problemu klinicznego. Wymaga to *innej* interwencji niż klasyczne CSBD: terapii akceptacji wartości i moralnej spójności, nie kontroli impulsów. Ujęcie **pragmatyczne**: nieważne, jak nazwiemy zjawisko — jeśli zachowanie powoduje *cierpienie* i *upośledzenie funkcjonowania*, wymaga interwencji. Kraus i wsp. (2016) wykazali w neuroobrazowaniu, że u części osób eskalacja kontentu wiąże się ze zmianami w prądkowiu brzuszny — co sugeruje istnienie podgrupy z mechanizmem podobnym do uzależnień, choć nie u wszystkich użytkowników z subiektywnym poczuciem problemu.

01 © Cztery sygnały kliniczne wymagające interwencji

1 · TOLERANCJA

Coraz **dłuższe sesje** dla tego samego efektu. Albo: potrzeba *bardziej ekstremalnych treści* — od mainstreamu do coraz bardziej niszowych. Mózg potrzebuje silniejszego bodźca.

2 · UTRATA KONTROLI

Wielokrotne próby ograniczenia bezskuteczne. Postanowienia („nie dziś”, „nie w tygodniu”) nie wytrzymują. Sesja planowana na 10 min — kończy się po 2–3 godzinach.

3 · WPŁYW NA SEKS PARTNERSKI

Trudności z erekcją albo orgazmem przy realnym partnerze/-ce. Zniekształcone oczekiwania (scenariusze, ciała). Mniej seksu partnerskiego, więcej samotnego.

4 · UKRYWANIE + WSTYD

Skomplikowane ukrywanie przed partnerem/-ką. Po epizodzie — wstyd, pustka, złość na siebie. Cykl: stres → pornografia → wstyd → więcej stresu.

02 Dwa różne problemy — różne interwencje

Grubbs i wsp. (2019) wykazali, że **nie każde subiektywne uzależnienie** jest CSBD. Czasem problemem jest *przekonanie* o uzależnieniu (postrzegane uzależnienie), nie samo zachowanie. Te dwa scenariusze wymagają *innej* terapii.

SCENARIUSZ A · KLINICZNE CSBD

Realne wskaźniki: tolerancja, eskalacja, utrata kontroli, sesje 2–6 godzin, dysfunkcje seksualne.

Interwencja: CBT (kontrola bodźców) + ACT (akceptacja cravingu) + ew. naltrekson off-label.

SCENARIUSZ B · POSTRZEGANE UZALEŻNIENIE

Normalna częstotliwość (1–2 razy/tyg.), brak tolerancji ani dysfunkcji, ale silne cierpienie z *przekonań*. **Interwencja:** psychoedukacja, praca z wartościami, ACT, terapia konfliktu między zachowaniem a tożsamością.

03 Samoocena — sześć obszarów

Odpowiedz uczciwie. Wynik ma *orientować Cię* w skali zjawiska, nie diagnozować.

CZĘSTOTLIWOŚĆ

— ile razy w tygodniu

CZAS TRWANIA SESJI

— ile minut/godzin

ESKALACJA TREŚCI

— czy szukam mocniejszych, niszowych

PRÓBY KONTROLI

— ile razy w ostatnich 6 miesiącach

WPŁYW NA SEKS PARTNERSKI

— erekcja, satysfakcja, częstotliwość

EMOCJE PO

— wstyd, pustka, złość, ulga, neutralność

04 Pornografia a związek — zasady rozmowy

PARTNER ODKRYWAJĄCY

Ból, poczucie zdrady, spadek samooceny są realne — i wymagają walidacji: „*Twój ból jest prawdziwy.*” Ale: pornografia to nie zdrada w sensie technicznym — to osobny problem, który *można razem rozwiązać*.

OSOBA UŻYWAJĄCA

Nie odrzucaj bólu partnera/-ki. Nie tłumacz „przecież to nikomu nie szkodzi” — jeśli szkodzi *tej osobie*, problem jest. Otwarta rozmowa o motywach, granicach, ew. terapii par.

ROZRÓŻNIENIE WPŁYWU

„Czy pornografia *wypierają* mi seks z partnerem? Czy *zmieniła* oczekiwania? Czy *zaniedbuję* partnera/-kę przez nią?” Jeśli tak na choćby jedno — to **klonicznie** dotyczy związku.

WSPÓLNE USTALENIA

Niektóre pary uznają umiarkowane korzystanie za neutralne, inne nie. *Każda umowa* jest legitymna, jeśli oboje partnerzy ją zaakceptowali. Bez moralizowania, bez ultimatum w punkcie zerowym.

Klucz: nie istnieje uniwersalna „granica problemu” mierzona w epizodach na tydzień. Liczy się *funkcja i konsekwencje*. Dla części osób 3× w tygodniu jest neutralne; dla innych ten sam wzorec destabilizuje życie. Pragmatyzm kliniczny (Kraus 2018): *nieważne, jak nazwiemy* — jeśli zachowanie powoduje realne cierpienie i upośledzenie funkcjonowania, wymaga interwencji. Hallberg i wsp. (2019, RCT): CBT online dla kompulsywnego korzystania z pornografii ma efekt $d = 0,66$. Nie wstyd, nie moralność — **kontrolowane korzystanie z odzyskaną wolnością wyboru**.